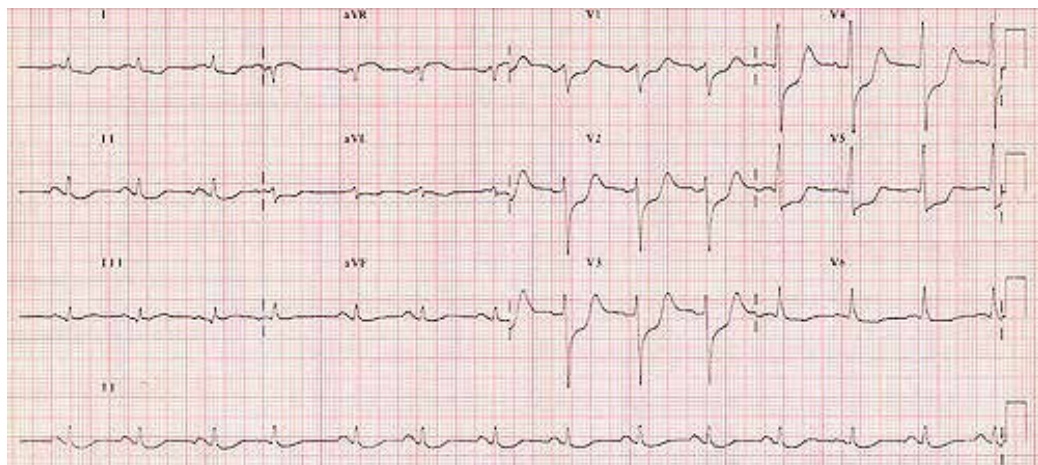




תרשים 9.40 אק"ג עם אוטם אחורי
צניחות ST בלידים קדמיים V1-V4. זוהי תמונה רציפרוקלית לאוטם אחורי.

הטיפול באוטם שריר הלב כולל:

- (1) הרגעת המטופל
- (2) מתן חמצן בהתאם למצבו של המטופל
- (3) ביצוע תרשים אק"ג
- (4) התקנת עירוי פריפרי
- (5) הזלפת נוזלים מבוקרת על פי מצבו של המטופל
- (6) מתן אספירין 300 מ"ג
- (7) טיפול בהפרעות קצב
- (8) טיפול בבצקת ריאות, אם יש
- (9) דיווח לבית החולים על הגעת מטופל עם אוטם טרי
- (10) מתן אנלגטיקה על פי הצורך

קרדיומיופתיה (Cardiomyopathy)

קרדיומיופתיה (קרדיו= לב, מיו= שריר, פתוס= סבל) משמעה חולי של שריר הלב. זהו השם של אוסף רחב של מחלות שכולן מובילות לשינויים ברקמת שריר הלב, לירידה בתפקוד ולבסוף גם לאי־ספיקת לב. יש גורמים רבים לקרדיומיופתיה, כגון גורמים גנטיים וגורמים נרכשים. הביטויים לקרדיומיופתיה כוללים מאפיינים קליניים, אלקטרוקרדיוגרפיים והדמייתיים. כל סוגי הקרדיומיופתיה קשורים בשכיחות גבוהה יחסית לדום לב פתאומי.

סוגי הקרדיومیופתיה

- קרדיومیופתיה היפרטרופית (hypertrophic cardiomyopathy: HCM)
- קרדיومیופתיה מורחבת (dilated cardiomyopathy: DCM)
- קרדיومیופתיה רסטרוקטיבית (restrictive cardiomyopathy: RCM)

קרדיومیופתיה היפרטרופית (Hypertrophic Cardiomyopathy: HCM)

קרדיومیופתיה היפרטרופית (HCM), כפי ששמה מעיד, היא מחלה הנוצרת בגלל הגדלה פתולוגית של מסת שריר הלב. שריר הלב גדל כל כך, עד שהוא בא על חשבון נפח החדר (בייחוד באזור הספטום החדרי - נקרא (asymmetrical septal hypertrophy: HCM). כמו כן, תנועת המיוקרד משתנה, נחלשת ונהרסת. אי־ספיקה דיאסטולית מופיעה, ולכן יש ירידה הדרגתית בתפוקת הלב. השריר המסיבי דורש כמות גבוהה מאוד של חמצן, כמות שבדרך כלל אינה מסופקת במלואה על ידי הקורונריים. בשל כך נוצרת פגיעה איסכמית מתמשכת בשריר הלב. בסופו של דבר שריר הלב עובר cardiac remodeling ומופיעה אי־ספיקת לב.

גורמים

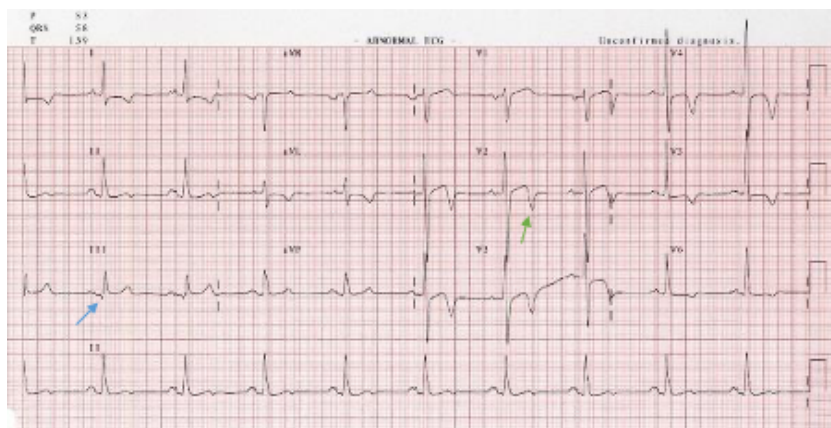
זו מחלה גנטית המופיעה באופן ספונטני במטופלים ללא מחלת מסתמים או יתר לחץ דם. גורמים נוספים הקשורים להופעת המחלה הם פגיעה במיקרוצירקולציה הקורונרית, בגירוי סימפטטי עודף ארוך טווח (מוביל ל־ventricular remodeling).

ביטויים קליניים

- כאבים אנגינוטיים
- פלפיטציות
- גודש ריאתי (תלונות של קוצר נשימה ועייפות)
- אורתופניאה (קוצר נשימה שמופיע בשכיבה)
- סינקופה או פרה־סינקופה במאמץ

ביטויים בתרשים אק"ג (תרשים 9.41)

- סימנים ל־LVH
- גלי Q צרים ועמוקים (פחות מ־0.04 שניות, אך עמוקים) - בייחוד בקיר התחתון
- הפרעות קצב, במיוחד ממקור שמעל ה־AV node
- אם יש היפרטרופיה אפיקלית ניכרת, רואים היפוך עצום של גלי T.



תרשים 9.41 אק"ג עם היפרטרופיה של הלב

סימני LVH בליד V4-V5.
חץ כחול: אפשר לראות גל Q בליד III.
חץ ירוק: היפוך גל T בליד V2-V3.

קרדיומיופתיה מורחבת (Dilated Cardiomyopathy: DCM)

משמעות המילה dilation היא הרחבה. בקשר לתפקוד הלב הכוונה במונח זה היא הגדלה של נפח חדרי הלב. קרדיומיופתיה מורחבת היא למעשה ההפך של HCM. המנגנון שמוביל להתפתחות HCM הוא הרחבה עצומה של שריר הלב, עד כדי כך שנפח החדר קטן. המנגנון של DCM כולל הרחבה חמורה כל כך של חדרי הלב, על חשבון הדופן השרירית של החדר, עד ששריר הלב מדולדל וחלש.

גורמים

- איסכמיה חריפה, במיוחד לאחר אוטם קדמי
- גורמים אידיופטיים
- כ-25% מהמקרים קשורים לגורמים גנטיים
- שימוש בקוקאין
- אלכוהוליזם
- היריון (איספיקת לב קשה על רקע מיוקרדיטיס יכולה להופיע אצל יולדת גם לפני או אחרי הלידה ונקראת peripartum cardiomyopathy)
- מיוקרדיטיס ויראלי

ביטויים קליניים

- עייפות
- קוצר נשימה במאמץ
- קוצר נשימה בשכיבה (אורתופניאה)
- סימנים לאיספיקת לב (בצקות פריפריות, גודש ורידי הצוואר והפטומגליה)

ביטויים באק"ג

אין קריטריון ספציפי ל-DCM, אך נהוג לומר שהאק"ג 'לא תקין'.

- סימנים ל-LVH
- גלי Q צרים ועמוקים - בייחוד בקיר קדמי
- וולטאז' נמוך בלידי הגפיים (QRS בעל אמפליטודה הקטנה מ-5 מ"מ)
- ציר שמאלי
- LBBB
- VPB's

קרדיומיופתיה רסטריקטיבית (Restrictive Cardiomyopathy: RCM)

קרדיומיופתיה רסטריקטיבית (מגבילה) היא הסוג הנדיר ביותר של קרדיומיופתיה. המאפיין הבולט ביותר של RCM הוא ירידה בהיענות השריר, כלומר ירידה ביכולת המילוי של הלב. עקב צניחת ה-preload, מופיעה גם פגיעה בתפוקת הלב.

גורמים

- גורמים אידיופטיים
- מחלות המאופיינות בהצטברות פתולוגית של חומרים בין תאי המיוקרד (myocardium) (עמילואידוזיס, המוכרומטוזיס, סרקואידוזיס)

ביטויים קליניים

- שלב מתקדם של מחלת הרקע (כגון עמילואידוזיס או המוכרומטוזיס או סרקואידוזיס)
- עייפות
- עילפון
- קוצר נשימה במאמץ
- קוצר נשימה בשכיבה (אורתופניאה)
- סימנים לאי-ספיקת לב (בצקות פריפריות, גודש ורידי הצוואר והפטומגליה)

ביטויים בתרשים אק"ג

אין קריטריון ספציפי ל-RCM.

- וולטאז' נמוך (מתחת ל-5 מ"מ בלידי הגפיים, מתחת ל-10 מ"מ בלידי החזה)
- BBB
- BVA
- גלי Q פתולוגיים

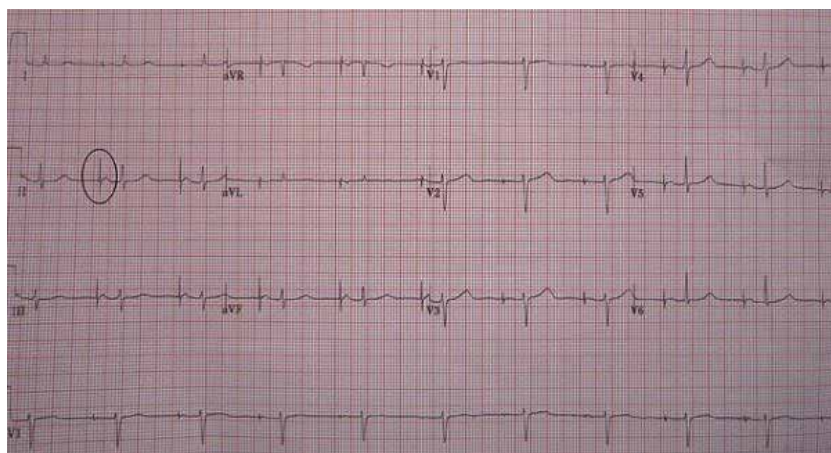
תרשים האק"ג במצבים ובמחלות שונים

קוצב (Pacemaker Rhythm)

יש קוצבי לב רבים שבהם משתמשים. חלקם מושתלים תוך־גופית וחלקם מחוברים חיצונית. חלקם מקציבים אזורים שונים בלב (עליות, חדרים, עליות וחדרים גם יחד), מופעלים בשל טריגרים שונים (טכיאריטמיות, ברדיקרדיה נרחבת), והם יכולים להגיב אחרת.

מאפיינים באק"ג (תרשים 9.42)

- **ספייק של קוצב** - זו פעילות חשמלית מהירה מאוד (כ־0.002 שניות); הוא מתבטא באק"ג כקו מאונך המופיע לפני גל P או לפני הקומפלקס (לפי הקוצב) (תרשים 9.42, מוקף עיגול)
- **חוסמי הולכה (BBB)** - אם יש קיצוב חדרי, רואים באק"ג תבנית של BBB
- קוצב שנמצא בחדר ימין (הנפוץ ביותר) - יציג תמונה של LBBB
- קוצב שנמצא בחדר שמאל (נדיר) - יציג תמונה של RBBB



תרשים 9.42 תרשים אק"ג עם קוצב עלייתי
מוקף בעיגול: ספייק של הקוצב לפני גל P.

רֶה־פּוֹלִרִיזָצִיָה מוקדמת (Benign Early Repolarization: BER)

רֶה־פּוֹלִרִיזָצִיָה מוקדמת (BER) היא תבנית של עליות ST שפירות בקיר קדמי. זהו ממצא תקין, המופיע במיוחד במטופלים צעירים (מתחת לגיל 50) ובריאם. ממצא זה נדיר מעל גיל 70. לעיתים קשה להבדיל בין BER ובין אוטם קדמי.